

文章编号: 1005-8982(2009)04-0631-02

手术联合放疗治疗腹壁外侵袭性纤维瘤病

陈 懿, 马洪良

(四川省肿瘤医院 骨科, 四川 成都 610041)

摘要:目的 报告 46 例腹壁外侵袭性纤维瘤病的临床资料并讨论其临床特点和治疗问题。方法 46 例均进行了手术治疗, 37 例行术后放疗。结果 治疗后随访 1~9 年, 11 例在术后 7~14 个月复发, 总复发率为 23.9%。行肿瘤广泛切除加术后放疗复发率为 7.7%, 行单纯肿瘤广泛切除复发率为 33.3%, 行肿瘤边缘切除(包括瘤内切除)加术后放疗复发率为 29.2%。结论 腹壁外侵袭性纤维瘤病具有浸润性生长特点, 局部切除后易复发, 术后放疗能降低复发率。

关键词: 侵袭性纤维瘤病; 手术; 放疗

中图分类号: R730.26

文献标识码: B

侵袭性纤维瘤病 (aggressive fibromatosis, AF) 又称硬纤维瘤、韧带样瘤, 临床比较少见, 国内外文献报道不多。我们采用手术切除结合术后放疗治疗腹壁外侵袭性纤维瘤病 46 例。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

本组 46 例。男 21 例, 女 25 例; 发病年龄 7~56 岁, 平均 33.5 岁。病程 3 个月~6 年, 17 例为发病后首次治疗, 29 例为治疗后复发 (多次复发, 多次住院手术, 只算 1 例)。部位: 肩部 5 例, 上臂 7 例, 前臂 2 例, 臀部 11 例, 大腿 9 例, 腘窝 3 例, 小腿 7 例, 1 例累及臀部和腿部, 1 例累及大腿、腘窝和小腿。全部病例均经病理确诊。

本组 32 例均以局部肿块为主要临床表现。大部分肿瘤与深部组织粘连无活动度, 肿瘤较小者可随肌肉活动, 与皮肤无粘连, 质地硬韧, 界限不清楚。肿瘤一般呈梭形, 复发病例肿瘤形状多不规则。11 例伴有疼痛, 但疼痛程度均较低。9 例伴有相邻关节活动受限, 其中 1 例累及大腿、腘窝、小腿伴有膝伸直功能受限和马蹄足畸形。本组患者均无明确的外伤史。

1.2 治疗方法

按照 Enneking 分期原则进行手术切除。选择适当的麻醉方法和手术体位以及手术切口。22 例沿肿瘤边缘扩大 2~3 cm 行肿瘤广泛切除, 其中 13 例行术后放疗, 放射剂量为 5 000 cGy。24 例行肿瘤边缘

切除或瘤内切除, 其中有 11 例累及重要神经和血管者, 均将神经和血管从包裹的肿瘤组织中分离, 并予以保留, 5 例行血管修复, 伤口愈合后行术后放疗, 放射剂量为 6 000 cGy。

1.3 统计学方法

本组资料使用统计软件为 SPSS 11.0, 统计方法为方差分析。

2 结果

本组未发现有肿瘤远处转移, 无死亡病例。治疗后随访 1~9 年, 平均 4 年。11 例在术后 7~14 个月复发, 总复发率为 23.9%。行肿瘤边缘切除 (包括瘤内切除) 加术后放疗 24 例, 有 7 例复发, 复发率为 29.2%。行单纯肿瘤广泛切除术 9 例, 有 3 例复发, 复发率为 33.3%。行肿瘤广泛切除加术后放疗 13 例仅 1 例复发, 复发率为 7.7%, 明显低于肿瘤边缘切除加术后放疗组和单纯肿瘤广泛切除术组 ($P < 0.05$)。肿瘤边缘切除加术后放疗组与单纯肿瘤广泛切除术组之间差异无显著性 ($P > 0.05$)。

3 讨论

侵袭性纤维瘤病, WHO 最新组织学分型定为腹壁和腹壁外侵袭性纤维瘤病两种, 以及常染色体显性遗传的 Gandner 综合征和奥蒙德病。本病组织学上含有分化好的胶原和纤维组织, 无变性、坏死, 无异性表现等, 具有浸润性生长特点, 腹壁外纤维瘤病的浸润性高于腹壁型, 局部切除后极易复发, 但不易

发生转移。

腹壁外侵袭性纤维瘤病的影像学诊断主要依靠 MRI 和 CT 扫描。CT 表现特点为肌肉内占位,可同时累及多块肌肉。增强扫描较平扫更能显示肿瘤边界,表现边界极不规则,肿瘤呈爪样蚕食正常肌肉。MRI 表现具有特征性,即肌肉内占位病变、相对均质、无坏死、无钙化和无脂肪组织。病灶在 T1WI 上呈低信号或等信号,T2WI 病灶均呈高信号,信号强度略低于皮下脂肪。MRI 多平面成像能明确地显示出病灶的部位、范围和形态,清晰地显示病灶边缘的爪状浸润,以及是否有包膜。MRI 和 CT 还能帮助评价肿瘤的侵袭范围以及与周围结构的关系。在术前行组织抽吸病理活检是诊断该肿瘤的可靠依据。

侵袭性纤维瘤病的治疗目前仍存在争议。治疗的难点在于其具有浸润性生长特点,容易累及重要神经血管,使手术彻底切除困难,复发率高。DALEN 等^[1]对 30 例侵袭性纤维瘤病患者 20 年以上的随访研究发现大多数患者仅有轻微症状和功能障碍,而且其症状严重程度与手术次数有关,并建议对无症状或仅有轻微症状的患者进行随访,如肿瘤稳定则不必进行治疗。

多数学者认为本病的治疗应以广泛彻底切除为其主要治疗手段,提出应切除包括肿瘤边缘周围 2~3 cm 正常组织。复发率达 25%~40%^[2]。LEITHNER 等^[3]认为手术中准确地判断肿瘤边缘,尽可能获得一个阴性切缘,对于控制肿瘤复发具有重要意义。但由于肿瘤呈浸润性生长无包膜,组织间隔的阻挡性差和偶尔呈多中心性发生^[4],以及术后复发再次手术患者,正确辨认肿瘤边缘并不容易。虽然可用术中冰冻切片来确定切缘,但是由于取材的局限性,LEITHNER 报道切缘阴性的复发率仍有 27%^[3]。本组 46 例中行广泛切除者只有 22 例,半数以上的患者由于肿瘤累及重要神经血管或侵及多个肌肉间隔而无法行广泛切除。对于累及重要血管神经的肿瘤,既要考虑切除范围,又要考虑重要的血管神经组织的保留和修复。由于神经结构的特殊性,神经束膜具有较好的屏障作用,先分块切除包绕神经的肿瘤,再利用显微外科技术进行仔细分离去除可能侵袭的神经外膜,保留神经束膜,维持神经的连续性,保留肢体的功能。对肿瘤累及血管也采取先分块切除包绕血管的肿瘤,再处理血管的办法,将血管从包裹的肿瘤组织中分离,并予以保留。如血管被肿瘤组织完全侵蚀,无法分离则连同血管将肿瘤

一并切除,用健康的静脉血管桥接修复。这样的切除方式多数只能达到边缘切除或瘤内切除,术后须辅助放疗以控制局部复发。笔者对无法行广泛切除的患者都行术后放疗,达到了与广泛切除相似的局部控制率。由于本病不易发生远处转移,患者能长期生存,不能为追求“无瘤”的切缘而不惜牺牲重要功能甚至截肢。

过去对于放疗在治疗本病的作用也存在争议,但近年来越来越多的文献报道显示,中~大剂量放疗对本病的治疗作用是肯定的^[5,6]。NUYTTENS 等^[7]对近 15 年有关手术和放疗治疗本病的文献分析认为放疗或手术结合放疗对肿瘤的局部控制明显优于单纯手术治疗。作为一种有效的辅助治疗手段,笔者对行广泛切除的患者术后用中等剂量 5 000 cGy 进行放疗,获得了较好的局部控制率。放疗的并发症包括疼痛、局部皮肤溃疡、肢体纤维化、水肿和肌挛缩等。接受放疗的 6~8 周期间,患者必须接受理疗,预防严重的肌挛缩,提高远期功能。其他治疗方法包括化疗、内分泌治疗、维生素 D3、NSAIDs 等药物治疗,临床报道效果不一,也缺乏足够说明其疗效的病例数量。对于无法切除的肿瘤部分病例得到了缓解^[7]。

参 考 文 献:

- [1] DALEN BPM, BERGH PM, GUNTERBERG BU. Desmoid tumors: a clinical review of 30 patients with more than 20 years' follow-up[J]. Acta Orthop Scand, 2003, 74: 455-459.
- [2] PIZA-KATZER H, RHOMBERG M. Extra-abdominal fibromatosis—extra-abdominal desmoid. Review and personal experiences [J]. Chirurg, 2000, 71(8): 904-911.
- [3] LEITHNER A, GAPP M, LEITHNER K. Margins in extra-abdominal desmoid tumors: a comparative analysis[J]. J Surg Oncol, 2004, 86(3): 152-156.
- [4] WAGSTAFF MJ, RAURELL A, PERKS AG. Multicentric extra-abdominal desmoid tumours[J]. Br J Plast Surg, 2004, 57(4): 362-365.
- [5] NUYTTENS JJ, RUST PF, THOMAS CR JR. Surgery versus radiation therapy for patients with aggressive fibromatosis or desmoid tumors: A comparative review of 22 articles[J]. Cancer, 2000, 88(7): 1517-1523.
- [6] EMILIOS E, PAKOS, PERICLES G. Desmoid tumours of the extremities and trunk: a review of the literature[J]. Int Orthop, 2005, 29(4): 210-213.
- [7] JANINIS J, PATRIKI M, VINI L. The pharmacological treatment of aggressive fibromatosis: a systematic review [J]. Ann Oncol, 2003, 14(2): 181-190.

(顾 靛 编辑)